

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 1 di 26
---	---	---

<i>Fasi</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Data</i>
Redazione	Gruppo di Lavoro	Luciano Gorelli	 LUCIANO GORELLI REGIONE TOSCANA/01386030488 22.11.2022 14:41:14 UTC	
Verifica	Dir. UOC Appropriatezza PDTAR	Maria Giovanna D'Amato	 D'AMATO MARIA GIOVANNA Regione Toscana/01386030488 22.11.2022 14:34:26 GMT+01:00	
	Direttore Dip. Medicina Interna e Specialistiche	Massimo Alessandri	 ALESSANDRI MASSIMO REGIONE TOSCANA/01386030488 13.12.2022 16:28:51 UTC	
	Dir. del Dipartimento della MG	Renato Fortunato Tulino	 TULINO RENATO FORTUNATO Regione Toscana/01386030488 07.12.2022 08:24:56 GMT+01:00	
	Dir. AD Neurologia	Roberto Marconi	 MARCONI ROBERTO REGIONE TOSCANA/01386030488 23.11.2022 11:47:20 UTC	
	Dir. Del Dipartimento Salute Mentale	Giuliana Galli	 GIULIANA GALLI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.12.2022 19:56:36 UTC	
	Dir. del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico	Vianella Agostinelli	 VIANELLA AGOSTINELLI Regione Toscana/01386030488 23.11.2022 13:26:33 GMT+00:00	
	Dir. del Dipartimento del Territorio	Anna Beltrano	 ANNA BELTRANO REGIONE TOSCANA/01386030488 22.11.2022 12:29:57 UTC	
	Direttore Servizi Sociali	Patrizia Castellucci	 CASTELLUCCI PATRIZIA REGIONE TOSCANA/01386030488 23.11.2022 14:03:09 UTC	
Approvazione	Direttore Sanitario	Dr.ssa Simona Dei	 SIMONA DEI REGIONE TOSCANA/01386030488 14.12.2022 10:04:20 UTC	
Controllo	Dirett. AFD Qualità, Rischio Clinico e Sicurezza delle cure	Dr. Roberto Monaco	 MONACO ROBERTO Regione Toscana/01386030488 14.12.2022 09:34:56 GMT+00:00	

Luogo e modalità di conservazione: AFD Prendersi Cura	Responsabile Dr.ssa Maria Giovanna D'Amato
--	---

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 2 di 26
---	---	---

Gruppo di Redazione composto da:

Dr. Luciano Gorelli, Direttore U.O.S.D. Geriatria Area Provinciale Senese, Coordinatore Gruppo Aziendale Multiprofessionale Demenze Azienda Usl Toscana Sud Est;

Dr.ssa Anna Beltrano, Direttore Dipartimento del Territorio;

Dr. Alessandro Tiezzi, Neurologia Ospedale San Donato Arezzo;

Dr.ssa Giuliana Galli, Direttore Dipartimento Salute Mentale;

Dr.ssa Sabrina Palei, Coordinatore professionale Servizio Sociale ACOT Area Aretina;

Dr. Roberto Marconi, Responsabile A.F. Neurologica;

Dr.ssa Vianella Agostinelli, Direttore Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche

La diffusione del presente documento è assicurata mediante pubblicazione nell'intranet aziendale. Essa inoltre verrà distribuita, a cura della struttura emittente, alla seguente lista di strutture organizzative:

1. Dipartimento del Territorio
2. Dipartimento Professioni Tecnico-Sanitarie, Riabilitazione e Prevenzione
3. Dipartimento Infermieristico e Ostetrico
4. Dipartimento della Medicina Generale
5. Dipartimento Salute Mentale
6. Dipartimento Servizi Sociali
7. Dipartimento di Medicina Interna e delle Specialistiche
8. Direttori di Zona-Distretto/SDS e Direttori di DMPO
9. Responsabili CDCCD
10. Associazioni dei familiari
11. AIMA
12. Terzo settore

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 3 di 26
---	---	--

INDICE

1. Premessa
2. Aspetti Generali
3. Scopo
4. Campo di applicazione e destinatari
5. Riferimenti normativi
6. Glossario, acronimi e abbreviazioni
7. Modalita' operative
8. Matrice delle Responsabilità
9. Monitoraggio
10. Bibliografia
11. Elenco allegati

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 4 di 26
---	---	---

1. Premessa

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) riguarda la gestione in modalità di Medicina di Iniziativa, da parte del team multiprofessionale definito dal modello Reti cliniche integrate e strutturate, di pazienti affetti dalla patologia oggetto del percorso, in fase stabile e senza complicanze gravi.

Il PDTA di patologia non si applica direttamente, ma costituisce utile strumento su cui basare il Piano Assistenziale Individuale (PAI) di ogni singolo cittadino, che appunto viene formulato tenendo presenti i PDTA delle patologie di cui ogni singolo cittadino è affetto.

Il PDTA Disturbi Cognitivi e Demenze è conforme al modello organizzativo gestionale dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze descritto nel documento “Linee di Indirizzo per l’organizzazione dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) nel contesto delle Reti Cliniche Integrate Strutturate Azienda Toscana USL Toscana SudEst”.

2. Aspetti generali

La demenza è una condizione clinica caratterizzata dalla presenza di deficit cognitivi, sintomi neuropsichiatrici e alterazioni funzionali con progressiva perdita dell’autonomia e vari gradi di disabilità fino alla completa non autosufficienza. Interessa dall’1 al 5 per cento della popolazione sopra i 65 anni; spesso viene rilevata solo in fase clinicamente avanzata ed è associata a una mediana di sopravvivenza dal momento della diagnosi di 3,3-11,7 anni (più di frequente 7-10). Secondo le stime del World Alzheimer Report del 2018, dagli attuali 50 milioni di pazienti con demenza, se rimanessero invariate l’incidenza della malattia e la tendenza all’invecchiamento il numero salirà a 82 milioni nel 2030 e 152 milioni nel 2050. Per quanto concerne la demografia, il World Population Ageing delle Nazioni Unite (Prince 2013) indica che in tutti i paesi sono uniformemente in atto una riduzione della proporzione dei nati e un parallelo incremento della proporzione dei soggetti anziani. Nella popolazione mondiale, i soggetti con oltre 60 anni di età sono passati dal 9,2% del 1990, all’11,7% del 2013 e sono attesi in una percentuale superiore al 20% nel 2050. In merito alla stima dell’incidenza attesa, occorre tenere presente che sembra essere in atto una tendenza recessiva nei paesi occidentali nel corso degli ultimi decenni che viene riferita da vari studi a un migliore controllo dei fattori di rischio cardiovascolare e anche a un più alto livello di formazione culturale della popolazione (Matthews 2013, Qiu 2018). Lo stesso andamento non sembra invece essersi manifestato nelle aree del mondo a minore indice di sviluppo, dove le previsioni dell’OMS risultano sottostimare i dati reali.

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 5 di 26
---	---	---

Negli USA, il più attento controllo dei fattori di rischio ha pressochè dimezzato negli ultimi 20 anni gli eventi cardiovascolari acuti, tra cui l'ictus e, per estensione, la demenza vascolare. Un'analisi di popolazione ha valutato che il controllo del diabete potrebbe ridurre del 3% i casi incidenti di demenza di Alzheimer, il controllo dell'ipertensione li ridurrebbe del 5% e la promozione dell'attività fisica del 13%.

È importante tenere ben presente che la demenza non è solo Malattia di Alzheimer nella sua variante precoce (< 65 anni) e tardiva, che resta la causa principale, ma comprende anche altre forme quali la Demenza Vascolare, la Malattia a Corpi di Lewy, la Demenza Frontotemporale e altre numerose forme singolarmente rare ma complessivamente significative. In molte delle demenze sopracitate vi può essere un substrato genetico, che necessita di essere indagato.

L'approccio diagnostico alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze è stato sensibilmente modificato negli ultimi anni con introduzione di nuovi criteri diagnostici (*Research criteria* IWG 2007, 2014 e NIA-AA 2011, 2018) che includono l'utilizzo di neuroimmagini convenzionali e quantitative, di indagini di medicina nucleare (PET-FDG e PET Amiloide), di marcatori biologici liquorali (proteina amiloide, tau, neurofilamenti a catena leggera) e di test molecolari per la diagnosi differenziale e la diagnosi precoce. Molta rilevanza ha assunto negli ultimi anni la diagnosi e il follow up dell' MCI (*mild cognitive impairment*) definito anche DNC minore (*disturbo neurocognitivo minore*) caratterizzato da disturbi di memoria e/o altri deficit cognitivi ancora sfumati con autonomie conservate, potenzialmente ma non invariabilmente predittivo di demenza.

La prevalenza del disturbo neurocognitivo minore varia dal 3 al 10% della popolazione mondiale (Zeisel et al., 2020).

In Italia si riscontra nel 19% delle persone con età maggiore di 65 anni, infatti secondo uno studio condotto a Roma dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica, in collaborazione con l'IRCCS S. Raffaele Pisana, ci sono attualmente circa 735.000 persone affette da questa forma di declino cognitivo. Nel 46% dei casi tale condizione clinica si trasforma entro tre anni in demenza vera e propria. Il 15% dei pazienti MCI, invece, torna a una condizione di normalità dopo un anno.

Le probabilità di regressione aumentano se il problema è diagnosticato nelle fasi iniziali di malattia e se quindi viene attuato un intervento strutturato. Per tale ragione, è sempre bene effettuare screening delle funzioni cognitive mediante test neuropsicologici standardizzati in persone con età maggiore di 65 e che presentino concomitanti fattori di rischio.

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 6 di 26
---	---	---

La diagnosi di demenza quindi, fin dalle fasi più precoci, è importante in quanto può permettere di intervenire tempestivamente avviando terapie farmacologiche e/o interventi di riabilitazione cognitiva e sociali in grado di ritardare la progressione della malattia e agire sulle capacità cognitive residue e la qualità di vita del paziente.

3 Scopo

Il modello assistenziale si pone i seguenti obiettivi:

1. Permettere una diagnosi tempestiva del disturbo neurocognitivo;
2. Permettere una presa in carico del paziente con demenza in applicazione alle reti cliniche integrate strutturate in modo da garantire l'omogeneità e l'equità dell'assistenza su tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
3. Garantire la presa in cura secondo i principi della continuità, dalla diagnosi all'attivazione e alla erogazione dei servizi;
4. Garantire una presa in carico del caregiver e della famiglia in un'ottica di sostegno e di empowerment in tutta la traiettoria di malattia della demenza, dalla diagnosi precoce all'end stage;
5. Garantire un Piano Assistenziale Personalizzato;
6. Monitorizzare l'andamento della patologia cercando di prevenire l'insorgenza di BPSD;
7. Monitorizzare l'appropriatezza terapeutica di farmaci controindicati secondo letteratura scientifica o di uso inappropriato (contenzione farmacologica);

4 Campo di applicazione e destinatari

Il presente documento si applica nel contesto di una rete della cronicità intesa come l'insieme di tutti i luoghi di cura a cui afferisce il paziente con declino cognitivo nel suo percorso di assistenza, dalla diagnosi precoce alla gestione delle problematiche del fine vita. Poiché la Medicina di Iniziativa tende a migliorare sia la diagnosi precoce che l'autocontrollo della malattia, è necessaria l'elaborazione di un PDTA che preveda il coinvolgimento del cittadino - utente, della famiglia, della comunità e dei professionisti della salute in modo multi professionale (team composto da medico, psicologo, infermiere, assistente sociale, educatore professionale, fisioterapista ecc.) per garantire la piena integrazione dei servizi territoriali residenziali (Modulo Alzheimer) o semiresidenziali diurni (caffè/atelier Alzheimer) con i servizi ospedalieri sia ambulatoriali che di degenza.

Sono destinatari del presente Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale:

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 7 di 26
---	---	---

- I pazienti con anamnesi positiva per disturbo neurocognitivo per un primo inquadramento diagnostico;
- I pazienti con demenza già diagnosticata per un follow up periodico di Medicina di Iniziativa al fine di cogliere precocemente i disturbi comportamentali e psicologici (BPSD) tali da richiedere un approccio multidimensionale;
- Non sono coinvolti i pazienti che necessitano di certificazione (Commissione di Invalidità, Patente di Guida, ecc.), per i quali va definito un percorso ad hoc con la collaborazione della Medicina Generale, Medicina Legale e INPS;

5 Riferimenti normativi e legislativi

- Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1402 del 11-12-2017;
- Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 147 del 23-02-2015;
- Linea Guida Consiglio Regionale Toscano “Sindrome Demenza Diagnosi e Trattamento” 2015;
- Piano Nazionale Demenze 2014;
- Delibera Direttore Generale ASL Toscana Sud Est 1056 del 2016 Adozione del documento programmatico e progettuale "Il nuovo approccio delle Reti Cliniche Integrate e Strutturate";
- Procedura aziendale PA-DTFD-002 Presa in cura domiciliare 10.11.2021;
- Decisione n.2 del 17.03.2021 Allegato A Organismo Toscano di Governo Clinico;
- DGRT 1055/ 2021 Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR1449/2017;

6 Glossario e acronimi

AFT: Aggregazioni Funzionali Territoriali

AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco

CDCD: Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze

DNC: Disturbo neurocognitivo

GAMD: Gruppo Aziendale Multiprofessionale Demenze

GRT: Giunta Regionale Toscana

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 8 di 26
---	---	---

MMG: Medico Medicina Generale

PAI: Piano Assistenziale Individuale

PAP: Piano assistenziale Personalizzato

PDTA: Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale

PND: Piano Nazionale Demenze

PRD: Piano Regionale Demenze Regione Toscana

UVA: Unità Valutativa Alzheimer

UVM: Unità Valutazione Multidimensionale

UVMD: Unità Valutazione Multidimensionale Disabilità

BPSD: Disturbi psicologici e comportamentali in demenza nota

7 Modalità Operative

Il percorso è articolato nelle seguenti 4 fasi, garantendo la continuità di cura in tutta la rete ospedale - territorio.

- FASE 1° Livello: identificazione dei pazienti con sospetto diagnostico da parte del MMG;
- FASE 2° Livello: inquadramento diagnostico e inizio terapia;
- FASE 3: follow-up periodico;
- FASE 4: definizione di un piano assistenziale individualizzato (PAI)

Fase 1° Livello - Identificazione dei pazienti con sospetto diagnostico da parte del MMG

Il Medico di Medicina Generale conosce il profilo cognitivo/comportamentale dei suoi assistiti e può identificare i segni clinici del decadimento cognitivo al loro insorgere, anche avvalendosi delle segnalazioni dei familiari. Il Medico di Medicina Generale nel sospetto di un declino cognitivo non precedentemente diagnosticato, attraverso un'anamnesi personale e familiare accurata ed orientata all'identificazione di deficit mnesici e/o disturbi comportamentali dispone l'esecuzione di alcuni accertamenti prima di decidere se inviare il proprio assistito ad una valutazione specialistica presso il

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 9 di 26
---	---	---

CDCD, come concordato nel Piano Nazionale Demenze. Inoltre può effettuare una valutazione preliminare per confermare o meno il sospetto di decadimento cognitivo tramite dei test di screening di primo livello (Test di Pfeiffer, GPCog o Mini-Cog).

Esami di base da richiedere:

- Esami di laboratorio di routine comprendenti anche vit. B12, ac. folico, ormoni tiroidei, esame tossicologico, lue, HIV-AIDS;
- Valutazione cardiovascolare (ECG ed eventuale Ecocolor doppler TSA);
- Esami di neuroimaging cerebrale (TAC cranio senza mdc);

Nel caso in cui il sospetto diagnostico venga avvalorato il MMG prescrive una richiesta con prenotazione CUP di “Visita geriatrica o visita neurologica con la dizione “PRIMA VISITA c/o CDCD”. Questa richiesta permetterà di prenotare la prima visita in agende CUP dedicate.

Tutte le informazioni raccolte dal Medico di Medicina Generale andrebbero incluse in una relazione di accompagnamento al primo invio al CDCD, che sintetizzi anche le eventuali comorbidità. Nella relazione il Medico riassume tutte le informazioni in suo possesso utili allo specialista per inquadrare il caso e formulare una diagnosi.

Fase 2° livello - Inquadramento diagnostico ed inizio terapia da parte del CDCD

Ogni CDCD dovrà garantire in sede distrettuale o ospedaliera una prima visita entro 30 - 60 giorni tenuto conto delle risorse a disposizione.

La durata della prima visita è di 60 minuti e ha come obiettivo quello di confermare o meno il sospetto diagnostico.

Il paziente affetto da decadimento cognitivo si caratterizza per una complessità clinica che deriva dalla comorbidità e dalla fragilità. È quindi necessario elaborare un approccio clinico - diagnostico dedicato e multidisciplinare da parte dell'équipe multiprofessionale del CDCD.

Durante la visita, oltre ad un esame obiettivo generale e neurologico, viene eseguita dal Medico del CDCD (Geriatra, Neurologo, Psichiatra) una valutazione neuropsicologica e funzionale che comprende:

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 10 di 26
---	---	--

- Valutazione Cognitiva:
 - Mini Mental State Examination;
 - Clock test;
- Valutazione psico-affettiva e comportamentale:
 - GDS (Geriatric Depression Scale);
 - CBI (Caregiver Burden Inventory);
 - NPI (Neuropsychiatric Inventory);
- Valutazione Funzionale:
 - ADL (Activities of Daily Living);
 - IADL (Instrumental Activities of Daily Living).

Inoltre, al fine di raggiungere una migliore definizione diagnostica nei casi iniziali dove è presente solo un lievissimo declino cognitivo rispetto a un precedente livello di prestazioni in uno o più domini cognitivi (attenzione, funzioni esecutive, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione percettivo- motoria e cognizione sociale) che non interferiscono con il funzionamento personale, sociale e lavorativo dell'individuo, lo specialista del CDCD potrà avvalersi, tramite percorso dedicato, del Neuropsicologo, parte integrante dell'equipe del CDCD, per l'esecuzione di test neuropsicologici di II° livello (Digit span, Test di Corsi, 15 parole di Rey, Figura complessa di Rey-Osterreith- recall, Memoria di Prosa, Trail Making Test, Test delle Matrici Attentive, Denominazione visiva, Fluenza verbale fonemica, Fluenza verbale semantica, Frontal Assessment Battery, Matrici Progressive di Raven). La valutazione neuropsicologica deve inoltre rilevare la consapevolezza di malattia, questo aiuterà in seguito a discernere le modalità più adatte per la comunicazione della diagnosi.

Eventuali ulteriori esami di laboratorio (biomarcatori di neurodegenerazione sul liquor, indagini genetiche) o strumentali (PET cerebrale con FDG, PET con amiloide, RMN funzionale) disponibili per un approfondimento diagnostico verranno valutati dallo specialista qualora lo ritenesse necessario per escludere cause rare o ereditarie di patologia dementigena. Tali indagini verranno effettuate presso l'AOUS o la Medicina Nucleare dell'Ospedale San Donato di Arezzo e dell'Ospedale Misericordia di Grosseto. Questo fa riferimento a quanto indicato nella Linea Guida Consiglio Regionale Toscana "Sindrome Demenza Diagnosi e Trattamento" 2015;

Nel caso di diagnosi di Demenza (Criteri DSM-V o ICD-11) lo specialista rilascerà certificazione per il paziente e per il Medico Curante relativa alla comunicazione della diagnosi, all'orientamento terapeutico con relativo piano terapeutico, nonché adeguato orientamento della famiglia ai servizi presenti sul territorio;

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 11 di 26
---	---	--

Fase 3 – Follow up periodico dei pazienti

Al fine di garantire la continuità di cura (rinnovo del piano terapeutico e rivalutazione dell’appropriatezza farmacologica) lo specialista del CDCD provvederà direttamente a prenotare ogni 6 mesi una visita di controllo con richiesta CUP con la dizione “Visita di Controllo c/o CDCD” utilizzando specifica agenda. La durata della visita di controllo dovrà essere di 30 minuti dove oltre all’esecuzione di test di I° livello (MMSE + ADL + IADL) finalizzati al monitoraggio dell’evoluzione della malattia viene valutata la comparsa di eventuali disturbi comportamentali e psicologici (BPSD). Inoltre Il personale del CDCD dovrà svolgere una funzione di counseling, dando così sostegno e accompagnando lungo tutto il percorso di cura il paziente e i suoi familiari fornendo adeguate informazioni sui servizi e sulle associazioni rappresentative di pazienti e familiari presenti sul territorio. Alle associazioni di volontariato di settore viene riconosciuto il ruolo attivo, propositivo e di supporto per le persone e le loro famiglie per la valorizzazione della propria condizione, spesso intervenendo nelle delicate fasi dell’insorgenza o nei momenti di maggiore difficoltà del caregiver. Possono inoltre collaborare con la realtà aziendale e territoriale alla realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e il supporto di progetti sia individualizzati che rivolti alla collettività.

Gli specialisti afferenti al CDCD dovranno garantire una reperibilità telefonica per il MMG per condividere notizie utili alla gestione del paziente e se necessario garantire una visita urgente, al fine di evitare accessi al Pronto Soccorso e/o ricoveri in Ospedale. Per i pazienti che accedono al Pronto Soccorso per disturbi comportamentali (BPSD) e/o nella gestione del delirium, gli specialisti afferenti al CDCD, qualora questo abbia una dimensione ospedaliera, dovranno garantire un contributo attivo nella gestione della fase acuta sia sotto forma di consulenza che di disponibilità a gestire specifici percorsi alternativi al ricovero, in conformità con l’ACOT e il Medico di Medicina Generale.

Fase 4 – Definizione di un piano assistenziale individualizzato (PAI)

Nella cura del paziente con demenza e più spesso nelle fasi più avanzate della malattia (CDR 3-4) è necessario definire un piano assistenziale che riesca a integrare l’appropriatezza terapeutica con i bisogni e le necessità della famiglia.

La cura del declino cognitivo, dalla diagnosi precoce alla gestione del fine vita, prevede una gestione multidisciplinare e multiprofessionale. Il team dell’UVM/UVMD realizza fin da subito una importante integrazione sociosanitaria avvalendosi degli specialisti del CDCD ogni volta che lo ritenga necessario.

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 12 di 26
---	---	--

Altre figure professionali (educatore, fisioterapista, associazione di volontariato di tutela del paziente) sono attori indispensabili nella realizzazione del PAP/Progetto di Vita sia nel setting domiciliare che nel setting residenziale e semiresidenziale (Centri Diurni Alzheimer - Moduli Alzheimer – Caffè e Atelier Alzheimer). Nelle fasi di fine vita l'integrazione del palliativista all'interno del team appare fondamentale sia nella cura domiciliare che in setting dedicati (hospice – RSA).

Fondamentale è rendere consapevole il caregiver sulla possibile evoluzione e gli stadi della malattia, fin dalle prime fasi, nonché aiutarlo a gestire le problematiche cognitivo-comportamentali fornendo l'educazione e le strategie alla gestione relazionale e tecnico-assistenziale della persona affetta da demenza.

Tra gli interventi definiti dal PAI dovrebbe essere previsto il supporto da parte infermiere esperto che possa indicare al caregiver corrette strategie assistenziali e relazionali, interventi di correzione dell'ambiente domestico rendendolo protesico e sicuro. Questo permetterebbe, in integrazione con gli altri servizi, il ritardo di una eventuale istituzionalizzazione piuttosto che la prevenzione di fattori di rischio (cadute, resistenza all'assistenza, adesione terapeutica ecc).

Alla rete dei servizi territoriali si accede tramite segnalazione del bisogno al PuntoInsieme. Tali strutture sono capillarmente distribuite nel territorio dell'Azienda USL Toscana Sud – Est e hanno il compito di informare, accogliere e accompagnare i cittadini che richiedono servizi sociosanitari o socioassistenziali. La segnalazione può avvenire o direttamente da parte dei familiari o dell'Amministratore di Sostegno oppure da parte del personale del CDCD, MMG, o di altri operatori della rete territoriale che assistono il paziente.

8 Matrice di Responsabilità

L'Equipe base dell'AFT è composta da:

- Medico di Medicina Generale (MMG);
- Infermiere;
- Collaboratore di studio/Oss;

L'équipe del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) è composta da:

- Medico Specialista (Neurologo, Geriatra, Psichiatra) con esperienza nella diagnosi, terapia e gestione della demenza;
- Psicologo con formazione neuropsicologica;

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 13 di 26
---	---	--

L'équipe della UVM è composta da:

- Medico Cure Primarie;
- Medico di Medicina Generale che ha in cura il paziente (MMG);
- Medico del CDCD;

- Assistente Sociale;
- Infermiere del territorio;

Il team multiprofessionale e multidisciplinare che garantisce la continuità di cura del paziente con demenza, in un'ottica di integrazione socio sanitaria prevede il coinvolgimento attivo di altre figure (educatore professionale, fisioterapista, nutrizionista, palliativista, associazioni di tutela del malato e del volontariato).

RESPONSABILI		MMG	Infermiere	CDCD	UVM	Paziente/caregiver
FASE / ATTIVITÀ ↓						
IDENTIF.	Individuazione pazienti candidati all'invio al CDCD e compilazione relativa richiesta " Prima Visita Declino Cognitivo"	R	C			I
	Esecuzione test di screening 1° livello					
ARRUOLAMENTO	Garantire entro 30-60 giorni la prima visita specialistica	I		R		I
	Inquadramento diagnostico			R		
	Ulteriore approfondimento diagnostico in day service - ulteriore valutazione neuropsicologica 2° livello	I	I	R		I
	Richiesta di visita di controllo	I	I	R		C
	Piano terapeutico, orientamento della famiglia ai servizi presenti sul territorio compreso AIMA	R	I	R	R	I
FOLLOW UP	Visita di controllo e assessment clinico e sociale			R	R	C
	Rivalutazione BPSD	I	I	R	R	C

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 14 di 26

RESPONSABILI		MMG	Infermiere	CDCD	UVM	Paziente/caregiver
	Rilevazione e registrazione in cartella dei parametri clinici (pressione arteriosa, ritmo e frequenza cardiaca) Esecuzione ogni 6 mesi di ECG con misurazione del QT	R	I	I		C
	Adeguamento della terapia	R	C	R		C
	Condivisione con UVM di inserimento Centri Diurni Alzheimer, Nuclei Alzheimer	R	I	C	R	C
	Consulenza del CDCD per UVM	R	I	C	R	C
	Raccordo con altre figure professionali	R	C	C		C
	Consulenza del CDCD nei casi di accesso al Pronto Soccorso	C	I	R	C	C
	Fornire educazione e strategie assistenziali al caregiver	C	R	C	C	C
SPECIFICI PAI FINE VITA	Informazione, consulenza, sostegno alla famiglia nell'appropriatezza circa SNG, PEG, nutrizione artificiale, Hospice	R	R	R	C	C
MONITORAGGIO	Monitoraggio e gestione liste di attesa	I		R	I	
	Valutazione del processo e dell'esito di sistema, attraverso l'analisi degli indicatori di monitoraggio	I		C	I	
	Supporto organizzativo per l'erogazione dei servizi territoriali, anche attraverso audit organizzativi.	I		C	C	

Legenda:

R = Responsabile; **C** = Collabora; **I** = È informato

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 15 di 26
---	---	--

9 Monitoraggio

Trasversali alle fasi sopra descritte, sono poi tutte le attività effettuate ai fini del monitoraggio del processo ed alla valutazione degli esiti, finalizzate alla successiva attuazione di eventuali azioni correttive e migliorative del percorso. Il monitoraggio relativo alla gestione del processo viene effettuato attraverso la rilevazione ed analisi annuale degli indicatori di seguito riportati.

Di Processo:

- % dei pazienti con richiesta di prima visita per demenza che hanno eseguito test di screening di primo livello (Test di Pfeiffer o Minicog) da parte del MMG;
- % di pazienti che ricevono la 1° visita presso il CDCD entro 30-60 giorni
- Riduzione delle visite per certificazione di non autosufficienza nei codici di prima visita - meno del 10% dei pazienti arruolati su proposta del MMG

Di Esito:

- % di pazienti che vengono monitorizzati ogni 6 mesi per il rinnovo del piano terapeutico;
- % di pazienti in terapia con antipsicotici con almeno un ECG nell'ultimo anno;

10 Bibliografia

- Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1402 del 11-12-2017
- Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 147 del 23-02-2015
- Linea Guida Consiglio Regionale Toscano "Sindrome Demenza Diagnosi e Trattamento" 2015
- Piano Nazionale Demenze 2014
- Delibera Direttore Generale ASL Toscana Sud Est n. 1056 del 2016 Adozione del documento programmatico e progettuale "Il nuovo approccio delle Reti Cliniche Integrate e Strutturate"
- Procedura aziendale PA-DTFD-002 Presa in cura domiciliare 10.11.2021
- Decisione n.2 del 17.03.2021 Allegato A Organismo Toscano di Governo Clinico
- DGRT 1055/ 2021 Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR1449/2017
- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.).
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).

Staff Direzione Sanitaria – AFD Prendersi cura	PDA-PCUR-003 PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE	Rev. n. 0 08/11/2022 Pag. 16 di 26
---	---	--

- Defrancesco, M., Marksteiner, J., Deisenhammer, E. A., Hinterhuber, H., & Weiss, E. M. (2009). Association of mild cognitive impairment (MCI) and depression. *Neuropsychiatrie*, 23(3), 144-150.
- Advancing research diagnostic criteria for Alzheimer’s disease: the IWG-2 criteria. *The Lancet Neurology*, 13(6), 614-629.
- Gauthier, S., Reisberg, B., Zaudig, M., Petersen, R. C., Ritchie, K., Broich, K., ... & Winblad, B. (2006). Mild cognitive impairment. *The lancet*, 367(9518), 1262-1270.
- Huckans, M., Hutson, L., Twamley, E., Jak, A., Kaye, J., & Storzbach, D. (2013). Efficacy of cognitive rehabilitation therapies for mild cognitive impairment (MCI) in older adults: working toward a theoretical model and evidence-based interventions. *Neuropsychology review*, 23(1), 63-80.
- Panza, F., Frisardi, V., Capurso, C., D’Introno, A., Colacicco, A. M., Imbimbo, B. P., ... & Solfrizzi, V. (2010). Late-life depression, mild cognitive impairment, and dementia: possible continuum?. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 18(2), 98-116.
- Schroeter, M. L., Stein, T., Maslowski, N., & Neumann, J. (2009). Neural correlates of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: a systematic and quantitative meta- analysis involving 1351 patients. *Neuroimage*, 47(4), 1196-1206.
- Wong, W. P., Hased, C., Chambers, R., & Coles, J. (2016). The effects of mindfulness on persons with mild cognitive impairment: Protocol for a mixed-methods longitudinal study. *Frontiers in aging neuroscience*, 8, 156.
- Zeisel, J., Bennett, K., & Fleming, R. (2020). World Alzheimer Report 2020: Design, dignity, dementia: Dementia-related design and the built environment.

11 Allegati

1. Elenco CDCD presenti nella Azienda USL Toscana Sud – Est
2. Diagramma del Percorso Diagnostico Assistenziale in corso di Demenza
3. Flow chart illustrativa e opzionale che il clinico può decidere di applicare in casi di demenza ad esordio precoce